DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: CIELO DE JESUS IMPATA REYES **Identificación** CC 29613163
Edad: 67 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS SA SUBSIDIADO 2025
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 04/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**441302**	**ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**	Y53	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

1	**452305**	**COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**	Y57	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES152 JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
452305 **COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS

Dx Postoperatorio: K296 OTRAS GASTRITIS

Tipo de Herida: SUCIA **Tipo de Anestesia:** SEDACION **Tipo de Cirugía:** PROGRAMADA
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 04/11/26 **Fecha Final** 04/11/26
Hora Inicio 10:25:00 **Hora Final** 10:45:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: ERGE
SE INTRODUCE GASTROSCOPIO OLYMPUS
ESOFAGO:MUCOSA NORMAL ,PASO FÁCIL POR EL CRICOFARINGEO, PERISTALTISMO,
VASCULARIDAD,CONSERVADOS, LINEA A 38 COINCIDE CON LA IMPRESIÓN HIATAL.
ESTOMAGO: EXPLORADO HASTA PÍLORO INCLUYENDO RETROVISIÓN PARA PEQUEÑA CURVA Y FONDO GÁSTRICO NORMALES.
MUCOSA DE CUERPO SIN ALTERACIONES. ANTRO CON ERITEMA EN PARCHES LEVES EN REGION PREPILORICA
PILORO FRANQUEABLE.
DUODENO: NORMAL HASTA SEGUNDA PORCIÓN
BIOPSIAS:FRASCO 1: ANTRO
***CONCLUSION:
1.GASTRITIS ANTRAL ERITEMATOSA LEVE
Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :
PROCEDIMIENTO BAJO SEDACIÓN ANESTESIOLOGA DRA RODRIGUEZ (FENTANILO, LIDOCAINA,
PROPOFOL).
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO,
PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE
REALIZADO POR JEISSON HINCAPIE
COLONOSCOPIA TOTAL
***INDICACIÓN: DOLOR ABDOMINAL
SE INTRODUCE COLONOSCOPIO OLYMPUS
INSPECCIÓN: NO ORIFICIOS FISTULOSOS, NO FISURAS, NO HEMORROIDES EXTERNAS, NO PLIEGUES CUTANEOS
REDUNDANTES.
TACTO RECTAL: ESFINTER NORMOTONICO, NO MASAS PALPABLES, DEDO DE GUANTE SALE LIMPIO.
ANOSCOPIA: CANAL ANAL SIN ALTERACIONES, LINEA DENTADA DE CONFORMACION HABITUAL, AMPOLLA RECTAL VACIA SIN
LESIONES MUCOSAS, RETROFLEXION SIN HEMORROIDES INTERNAS. COLONOSCOPIA: SE AVANZA HASTA ILEON DISTAL EL
CUAL SE ENCUENTRA CON MUCOSA DE CARACTERISTICAS NORMALES, EN RETIRADA SE EXPLORAN TODAS LAS PORCIONES DEL
COLON ENCONTRANDO ESCASOS ORIFICIOS DIVERTICULARES EN COLON SIGMOIDES, DEMAS AREAS EXPLORADAS SIN

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

LESIONES. PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES APARENTES. PREPARACIÓN BOSTON CD: 3, CT: 3, CI: 3 9/9.
***CONCLUSIÓN:
1.DIVERTICULOSIS DEL COLON SIGMOIDES SIN SIGNOS DE COMPLICACION

Tejidos enviados a patología : SI [X] **NO** [ ]

BIOPSIAS:FRASCO 1: ANTRO

JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ
Reg. 1115066530
CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***